

ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Rapport d'Analyse Respiratoire et Oxymétrique

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

☎ 0796 222 597 / 0663 755 584

📍 Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi
en face des urgences, Guelma

✉ selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENT & CONTEXTE CLINIQUE

Nom :	AMIROUCHE hammed L.	Mo-	ID Patient :	20260902-132
Genre :	Masculin		Période enreg. :	06 :39 :00 – 15 :24 :30
Âge :	37 ans (17/01/1989)		Durée totale :	525,5 min (8h 45min 30s)
Taille / Poids :	180 cm / 115 kg		Durée valide :	525,5 min (100,0%)
IMC (kg/m ²) :	35,5 (Obésité classe II)		Date d'examen :	02 Septembre 2026
Motif / Contexte : Obésité sévère , ronflement nocturne majeur (Index 132,2/h), somnolence diurne pathologique, suspicion clinique de SAHOS critique.				



Scanner pour accéder au tracé complet et dossier numérique

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE POLYGRAPHIQUE

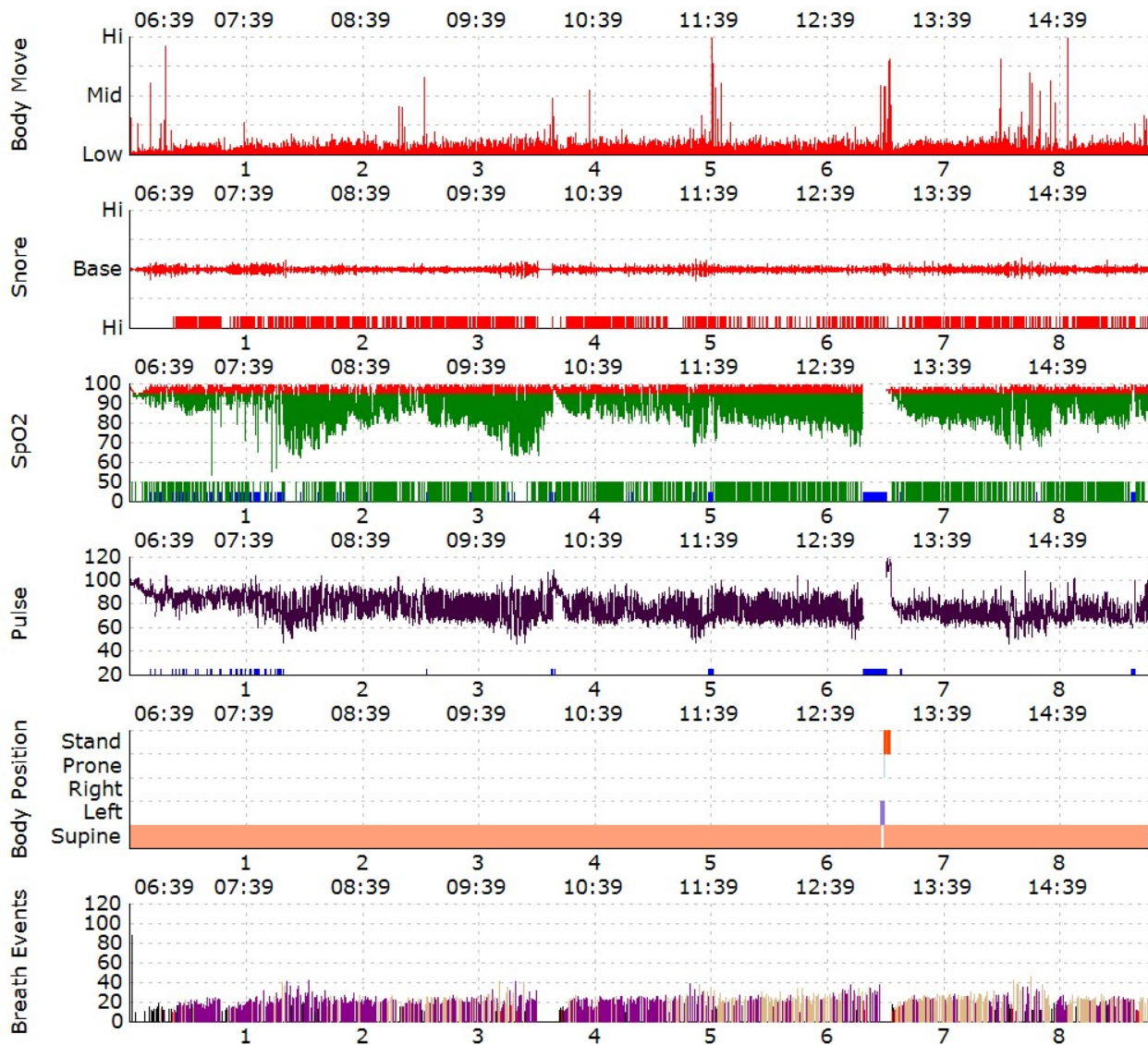


FIGURE 1 – **Enregistrement continu multicanal** : Mouvements corporels (Actimétrie), Signal de ronflement, Oxymétrie de pouls (SpO_2), Fréquence cardiaque, Encodage des postures et Histogramme temporel des événements respiratoires.

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS DU SOMMEIL

2.1. DISTRIBUTION POSTURALE ET IMPACT VENTILATOIRE

TABLE 1 – Événements respiratoires et désaturations selon la position corporelle

Position	Durée (min)	%	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	IDO (/h)	Total Resp.
Dorsale (SUP)	522,1	99,4%	61	432	15	286	651	74,8	794
Ventrale (PRO)	0,0	0,0%	0	0	0	0	0	—	0
Côté gauche (LAT-G)	1,8	0,3%	0	0	0	0	0	—	0
Côté droit (LAT-D)	0,0	0,0%	0	0	0	0	0	—	0
Debout (STAND)	1,6	0,3%	0	0	0	0	0	—	0
Total / Moyenne	525,5	100%	61	432	15	286	651	81,4	794

2.2. CINÉTIQUE DE L'OXYMÉTRIE DE POULS (SpO₂)

TABLE 2 – Paramètres oxymétriques détaillés et hypoxémie nocturne

Paramètre Oxymétrique	Valeur	Norme / Référence
SpO ₂ maximale (%)	99	95 – 100 %
SpO ₂ minimale (Nadir oxymétrique)	57	≥ 90 %
SpO ₂ moyenne (%)	91	≥ 95 %
Durée cumulée de désaturation en oxygène (min)	286,4	—
Durée moyenne d'une désaturation	26,4 s	—
Durée maximale d'une désaturation	77,0 s	< 20 s
Nombre total d'événements de désaturation (DO)	651	—
Index de Désaturation en Oxygène (IDO global)	81,4 /h	< 5 /h
Index de Désaturation en Décubitus Dorsal	74,8 /h	< 5 /h
Temps passé sous 95% de SpO ₂ (min)	269,4	54,5 % du temps total
Temps sous 90% de SpO ₂ (T90 en min)	191,5	38,8 % du temps total
Temps passé sous 85% de SpO ₂ (min)	114,2	23,1 % du temps total
Temps passé sous 80% de SpO ₂ (min)	42,1	8,5 % du temps total

2.3. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (APNÉES & HYPOPNÉES)

TABLE 3 – **Caractérisation et indexation ventilatoire**

Catégorie Événementielle	Nombre	Index (/h)
Apnées (Total : 733)		
Apnées Obstructives (SAOS)	432	
Apnées Centrales (AC)	15	
Apnées Mixtes (AM)	286	
Durée cumulée des apnées	280,2 min	(53,3% du temps total)
Durée moyenne / Durée maximale	22,9 s	46,6 s
Hypopnées (Total : 61)		
Nombre total d'hypopnées	61	7,0
Durée cumulée des hypopnées	15,3 min	(2,9% du temps total)
Durée moyenne / Durée maximale	15,1 s	88,9 s
Synthèse Ventilatoire Globale		
Nombre cumulé d'événements respiratoires	794	—
Durée totale cumulée sous événement (min)	295,5 min	56,2 % du sommeil
Durée moyenne d'un événement respiratoire	22,3 s	—
Indice d'Apnées-Hypopnées (IAH)	—	90,7 /h
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	—	81,4 /h
Respiratory Disturbance Index (RDI)	—	90,7 /h

3. TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE

TABLE 4 – **Récapitulatif des biomarqueurs polygraphiques**

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
SpO ₂ moyenne (%)	91 %	SpO ₂ minimale (%)	57 %
IDO global (/h)	81,4	IDO dorsal (/h)	74,8
Nombre SAOS	432	Nombre Apnées Centrales	15
Nombre Apnées Mixtes	286	Total Apnées	733
Index d'Apnées (IA /h)	83,7	Nombre d'Hypopnées	61 (IH : 7,0/h)
IAH global (/h)	90,7	RDI (/h)	90,7
FC moyenne (bpm)	76,1	FC min / FC max (bpm)	47 / 119
Index de Ronflement (/h)	132,2	Changements de position	49
Durée max Apnée (s)	46,6	Durée max Hypopnée (s)	88,9

4. AVIS MÉDICAL ET CONDUITE À TENIR

Diagnostic Polygraphique

Examen polygraphique d'une sévérité extrême, mettant en évidence un **Syndrome d'Apnées-Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) sévère hyper-dense**, caractérisé par :

- Un **IAH critique à 90,7 /h** (794 événements au cours de 525,5 minutes d'enregistrement, soit un événement toutes les 40 secondes).
- Une durée totale cumulée en apnée/hypopnée de **295,5 minutes (56,2% du temps de sommeil passé en asphyxie ventilatoire)**.
- Un retentissement oxymétrique majeur : **IDO à 81,4 /h** (651 désaturations, durée maximale de désaturation de 77 secondes), nadir à **57%**, et un **T90 massif de 191,5 minutes (38,8% de l'enregistrement sous hypoxie)**.

Conduite à Tenir & Recommandations Thérapeutiques 1. Traitement par Pression Positive Continue (PPC) en urgence vitale :

- Indication formelle à une titration par **PPC en mode auto-piloté (Auto-CPAP)** avec interface bucco-nasale adaptée aux résistances élevées.

2. Bilan Cardiovasculaire Spécialisé

3. Mesures d'Hygiène du Sommeil et Posturales :

- Mise en place d'une thérapie positionnelle pour limiter le décubitus dorsal strict.

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24